

Un niño en edad escolar en su clínica

Para médicos de familia, enfermeros y profesionales de la salud — cuidar a un niño autista en primaria (aproximadamente de 6 a 11 años).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un niño se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos a la vez — vívidos por dentro, tenues por fuera, y costosos de cambiar. La escuela es a menudo la primera prueba de estrés real: ruidosa, visualmente saturada e impredecible, lo que agota la atención que debería dedicarse a todo lo demás. Muchos niños **mantienen la compostura en la escuela y colapsan después**, incluso en su sala de espera. Trabajar *con* el túnel, y no *contra* él, es la clave.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
«Está bien en la escuela», colapsos (<i>meltdowns</i>) o bloqueos (<i>shutdowns</i>) en casa o en la clínica	El niño ha camuflado todo el día; el hogar —y su consultorio— es donde la máscara finalmente cae
Dolores de estómago, de cabeza, «no quiere comer»; sin causa orgánica clara	La alta carga sensorial y social se manifiesta a través del cuerpo; también es común la co-ocurrencia de problemas GI y del sueño
Dificultad para empezar, cambiar o parar; parece «perezoso» o desafiante	Inercia autística — cambiar la vía mental cuesta una energía real, no es falta de voluntad
Pérdida repentina de habilidades que tenía el año pasado	A menudo es burnout / un cambio en los recursos atencionales bajo sobrecarga, no una regresión real
Toma las cosas literalmente; necesita tiempo extra para responder	Comunicación literal y de canal único + tiempo de procesamiento

Intente esto

- **Envíe un formulario previo a la visita** (el AHAT de AASPIRE, autismandhealth.org) y pregunte a los padres qué ayuda; acepte auriculares, gafas de sol y un objeto de confort.
- **Reserve el horario más tranquilo**, atenúe las luces, reduzca los pitidos; permita la presencia de un adulto de confianza en la sala.
- **Explique cada paso antes de hacerlo**, con frases cortas y literales; permita que el niño haga stimming o sostenga un objeto de interés.
- **Pregunte sobre la carga escolar y la recuperación**, no solo sobre los síntomas — «¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse después de un día escolar?» revela la sobrecarga.
- **Co-creen una rutina de salud sencilla** (misma sala, misma secuencia) para las visitas recurrentes.

Evite esto

- Tratar la compostura camuflada como «está bien», o un bloqueo como un rechazo a colaborar.

- Instrucciones verbales largas, procedimientos sorpresa o frases como «¡sé valiente!».
- Presionar más cuando las habilidades han caído — la respuesta basada en la evidencia al burnout es **reducir las demandas y restaurar el descanso y los intereses**.

Cuándo buscar más apoyo

Observe el **burnout autístico** (agotamiento crónico, pérdida de habilidades y reducción de la tolerancia a los estímulos) — es *distinto de la depresión* y del estrés ordinario, y se agrava con el camuflaje. Dépile las co-ocurrencias comunes: **ansiedad, TDAH (AuDHD), problemas de sueño y GI**. Pregunte directamente sobre la asistencia escolar y el acoso. Oriente hacia el apoyo del coordinador de necesidades especiales (SENCO/SEND) y grupos de padres dirigidos por autistas.

Si el niño es una niña

Las niñas a esta edad **camuflan intensamente** y a menudo pasan desapercibidas o son mal diagnosticadas (ansiedad, «tímida»). Tome en serio la preocupación parental incluso cuando los profesores vean a una niña callada y dócil — el coste se paga fuera de la vista.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la brève sobre el **Monotropismo** y el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.2 & 4). Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico**. Adáptelo al niño individual.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019, *Monotropism at School*; 2023); Dwyer (2025); Edgar (2024, regression/burnout); Raymaker et al. (2020); AASPIRE AHAT; Kelly Mahler (2024). Las citas completas están en los borradores fuente.